



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مريم محمد حسن محمود
المحافظة : المنوفية الحي / المدينة : أشمون
رقم البطاقة : 26910231400804 رقم التليفون : 01157833342
العنوان : ++
العمر (تاريخ الميلاد) : 23-10-1969 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي محوسب للصدر [10865] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مريم محمد حسن محمود National ID: 26910231400804	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي CT scan of the chest.
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



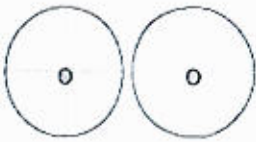
Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:
1- Name : **مريم محمد حسن محمود** Sex: **Female** 3- Medical number: **83200627** Old Med : **1190-2024**
2-ID number: **26910231400804** Patient Age : **55 Y**



Family history	Family History strong +velh	Phone	Phone 01094761500	BMI	SP	REASON OF MDT	REASON OF NOT POST OPERATIVE
marital status	Marital Status W/DCA	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP A	Date of MDT	Date Of MDT 19/05/2024
Co morbidity	Co Morbidity htn,cs	Menopausal status	Menopausal Status POSTMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data					
Breast Imaging :			Mets Workup : ct cap:free		
BX IDC	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
BX COMMENT: It gli	ER COMMENT: +ve	PR COMMENT: +ve	Her 2 Neu COMMENT: -ve	SISH COMMENT :	25
T		N		M	
Sonomammography					
PATIENT HISTORY post LT MRM (upfront):free margins ALND 6/12					
MDT OUTCOME & PLAN					
MDT OUTCOME & PLAN for adj AC x4-->taxotere x4-->PORT-->AI x 5 yrs					

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition



الكلية الطبية
الجامعة الوطنية للتعليم
مستشفى عبد الموكوكو

قسم الباثولوجي

المرضى : 54 : سنة 2024 (248 : تاريخ 2024)
المرضى : 54 : سنة 2024 (248 : تاريخ 2024)
المرضى : 54 : سنة 2024 (248 : تاريخ 2024)
المرضى : 54 : سنة 2024 (248 : تاريخ 2024)

NATURE OF SPECIMEN :

Left modified radical mastectomy

GROSS :

Modified radical mastectomy specimen measured 25x24x10cm, skin ellipse measured 24x16cm with unremarkable nipple and areolar and attached axillary tail 9x8cm. Serial cuts revealed two gray, white ill-defined masses measured 4x3x2.5cm, and 2.5x2x1.5cm away from each other by 2.5cm, located 3.5cm from deep margin, rest of cut section was rubbery yellow. Dissection of axillary tissue revealed 16 nodules measured up to 2.5x1.5cm.

MICROSCOPY :

Sections examined revealed bifocal invasive duct carcinoma (NST). The tumor forms trabeculae, nests and clusters of anaplastic ductal cells of moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules, occasional mitotic figures.

The tumor infiltrates among desmoplastic stroma. Also seen ductal carcinoma in situ solid subtype. There was mild lymphocytic infiltrate and positive lymphovascular and perineural infiltrate. Deep margin, nipple, areola and skin were free.

The examined 16 lymph nodes revealed 5 lymph nodes infiltrated by tumor.

DIAGNOSIS :

Left modified radical mastectomy,
MULTIFOCAL INVASIVE DUCT CARCINOMA (NST), GRADE II,
WITH DUCTAL CARCINOMA IN SITU SOLID SUBTYPE,
POSITIVE LYMPHOVASCULAR AND PERINEURAL INFILTRATION,
ALL SURGICAL MARGINS, NIPPLE AND AREOLA WERE FREE,
LYMPH NODE STATUS 5/16
(T2m N2 R0).

RECOMMENDATION :

3000 words

الاسم: مريم محمد حسن

POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF CHEST:

Known case of breast cancer

- ' No available previous studies*
- Bilateral few small subpleural nodules are seen .*
- Thickened left breast skin .*
- The trachea, main stem bronchi as well as their lobar and segmental divisions are normal.*
- No evidence of mediastinal or hilar nodal enlargement.*
- No pleural collections.*
- Normal cardiac size and configuration.*
- No detectable lesions in the chest wall.*

POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

- The liver is seen average in size and tissue density. It shows hypodense focal lesion is seen at segment V measures about 1 cm likely deposit .*
- The intra and extra-hepatic biliary radicles are normal.*
- The pancreas and spleen are normal.*
- No focal renal lesions could be seen. with no masses*
- Right and left supra renal glands are normal.*
- No CT evidence of enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.*
- No ascites.*
- Scanned pelvis showed no masses*

Dr. Mohamed Elghanam , MD
Dr. Rehab Abd-Elnasser , MSc



Patient Name: Mariam Mohamed Hussein Mahmoud	Date : 09/04/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 1190/2024	Pat. ID: 98244

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM.

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

09/04/2025 11:28 AM